

TEMA 3.11 • ENDOCRINOLOGÍA

Nódulo Tiroideo

PERFIL EUNACOM 1.03.2.010
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Nódulo Tiroideo — Algoritmo Diagnóstico

Epidemiología

- Muy frecuente (palpable ~5%; ecográfico hasta 70%)
- La gran pregunta: ¿es benigno o maligno?
- Solo ~5–10% son malignos

Algoritmo Diagnóstico

''' Nódulo tiroideo detectado | | TSH ↓ → Gammagrafía tiroidea |
| Nódulo caliente → Benigno → Tratar **hipertiroidismo** |
Nódulo frío/tibio → Ecografía + PAAF | TSH normal o ↑
Ecografía tiroidea (TI-RADS) | TI-RADS 1–3 → Observar (benigno)
| TI-RADS 4 → PAAF (biopsia) | TI-RADS 5 → PAAF (alta sospecha maligno) '''

Clasificación TI-RADS (ecográfica)

TABLA 3.11.1: CATEGORÍA VS PROBABILIDAD MALIGNIDAD		
CATEGORÍA	PROBABILIDAD MALIGNIDAD	CONDUCTA
TI-RADS 1	0%	Solo observar
TI-RADS 2	< 2%	Solo observar
TI-RADS 3	< 5%	Seguimiento o PAAF > 2,5 cm
TI-RADS 4	5–80%	PAAF
TI-RADS 5	> 80%	PAAF

Características ecográficas de sospecha maligna

- Hipoecogenicidad marcada
- Márgenes irregulares
- Microcalcificaciones
- Más alto que ancho

- Extensión extracapsular

Gammagrafía: ¿Cuándo se pide?

- Solo si TSH está **baja** (hipertiroidismo) → hay nódulo autónomo
- Nódulo **caliente** (hipercaptante) = benigno (hiperfuncionante)
- Nódulo **frío** (hipocaptante) = mayor riesgo de malignidad → agregar ecografía + PAAF

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La gammagrafía NO es el primer examen. Se pide solo si hay hipertiroidismo para buscar el nódulo tóxico.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente con nódulo tiroideo palpable. TSH 0,05 mU/L (suprimida). ¿Cuál es el siguiente paso?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Nódulo Tiroideo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Estudio del nódulo tiroideo: TSH + ecografía. Si TSH suprimida → cintigrafía.
- Nódulo caliente en cintigrafía = adenoma tóxico. Nódulo frío = hacer PAAF.
- TI-RADS 1-2: no puncionar. TI-RADS 3-5 con >10 mm: PAAF.
- TI-RADS 5 (altamente sospechoso): PAAF siempre.
- La biopsia tiroidea es citológica con aguja fina (PAAF), no histológica.
- Bocio nodular se maneja igual que nódulo tiroideo.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (NÓDULO TIROIDEO)

PREGUNTA 1

Paciente con nódulo tiroideo palpable. TSH 0,05 mU/L (suprimida). ¿Cuál es el siguiente paso?

- A) PAAF del nódulo
- B) Cintigrafía con yodo radioactivo
- C) Tiroidectomía directa
- D) Observar y controlar en 6 meses
- E) Iniciar levotiroxina supresiva

RESUMEN: NÓDULO TIROIDEO

El nódulo tiroideo es frecuente y su importancia radica en descartar cáncer de tiroides y adenoma tóxico. Se estudia con TSH + ecografía. Si TSH suprimida (sospecha de hipertiroidismo): cintigrafía con yodo radioactivo. Nódulo caliente = adenoma tóxico (tratar hipertiroidismo). Nódulo frío = hacer PAAF. Si TSH normal: evaluar aspecto ecográfico con TI-RADS (1-5). TI-RADS 1 = tiroides normal. TI-RADS 2 = benigno (quiste simple, no puncionar). TI-RADS 3-4 = PAAF si >10 mm. TI-RADS 5 = altamente sospechoso, PAAF siempre (difícil si <5 mm). La biopsia es citológica con aguja fina (no histológica).